

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE HABILIDADES DE REGULACIÓN EMOCIONAL (ERSQ-27)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Dimensional de las 9 Habilidades del Modelo TEK de Berking

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Habilidades de Regulación Emocional (ERSQ: 27 reactivos).
Nombre Original (Inglés)	<i>Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ)</i>
Autores Originales	Drs. Matthias Berking y Hansjörg Znoj (2008), University of Bern.
Validaciones Hispanas	Gómez-Acosta et al. (2020); Berking, Wirtz, Svaldi & Hofmann (2014).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Entrenamiento en Competencias Emocionales (TEK), DBT y TCC.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico de 27 reactivos distribuidos en 9 factores con escala de 5 niveles (0 a 4).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (desde 16 años). Pacientes clínicos con trastornos afectivos y personalidad.
Tiempo de Administración	4 a 6 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto (Creative Commons / BMC Psychiatry) para uso clínico, docente y de investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO MODULAR TEK DE MATTHIAS BERKING

El ERSQ operacionaliza el modelo sistemático de regulación emocional adaptativa formulado por Matthias Berking en el marco del Entrenamiento en Competencias Emocionales (**Training Emotinaler Kompetenzen - TEK**). Berking postula que la desregulación emocional transdiagnóstica (presente en depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y TLP) no es un rasgo unitario inmutable, sino la consecuencia directa de déficits específicos en un conjunto secuencial y jerárquico de 9 habilidades de autorregulación.

El modelo postula que para regular exitosamente un estado afectivo aversivo, el individuo debe ser capaz de: (1) percibir conscientemente sus emociones; (2) conectar con las sensaciones somáticas asociadas; (3) clarificar y etiquetar el afecto; (4) comprender su significado funcional; (5) aceptar la experiencia interna sin luchar; (6) tolerar el malestar sin recurrir a conductas lesivas de escape; (7) autocalmarse y ofrecerse apoyo afectuoso; (8) modificar y modular activamente el afecto hacia la valencia positiva; y (9) mantenerse comprometido en la acción hacia metas a pesar de la presencia del dolor.

A nivel neurofuncional, el ERSQ mide el grado de control prefrontal inhibitorio (DLPFC y vmPFC) y cíngulo anterior dorsal sobre los circuitos de reactividad emocional subcortical amigdalina e insular.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE LAS 9 HABILIDADES (3 ÍTEMS C/U)

Habilidad Regulatoria	Ítems (27)	Nº Ítems	Definición Operativa y Conducta Evaluada
1. Consciencia Atencional	1, 12, 19	3 ítems	Atención consciente deliberada hacia los propios sentimientos.
2. Sensación Corporal	7, 14, 24	3 ítems	Consciencia interoceptiva de los efectos somáticos de las emociones.
3. Claridad y Etiquetado	6, 13, 25	3 ítems	Capacidad de identificar, diferenciar y poner nombre a los afectos.
4. Comprensión Funcional	3, 11, 20	3 ítems	Entendimiento de las causas y significados de las reacciones anímicas.
5. Modificación Activa	2, 4, 10, 21 (*)	3 ítems	Influencia voluntaria sobre el afecto negativo y generación de emociones positivas.
6. Aceptación Afectiva	5, 17, 23	3 ítems	Disposición a experimentar el malestar sin luchar ni rechazarlo.
7. Tolerancia al Malestar	18, 26	2-3 ítems	Seguridad y convicción subjetiva de poder soportar afectos intensos.
8. Autovalidación / Apoyo	9, 15, 27	3 ítems	Autocompasión, consuelo y tranquilización activa en momentos de angustia.
9. Afrontamiento a Metas	8, 16, 22	3 ítems	Perseverancia en metas importantes a pesar del miedo o malestar.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión global: alfa de Cronbach de la escala total de 0.90 a 0.94 en muestras clínicas y comunitarias (Berking & Znoj, 2008; Gómez-Acosta et al., 2020). Las 9 subescalas presentan alfas entre 0.72 y 0.86. Fiabilidad test-retest $r = 0.78$ a las 4 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la estructura de 9 dimensiones de primer orden subordinadas a un factor macro general de competencia regulatoria ($CFI = 0.94$, $TLI = 0.92$, $RMSEA = 0.049$), confirmando la pertinencia del modelo jerárquico.
Validez Concurrente y Clínica	Correlaciones inversas muy robustas con sintomatología depresiva (BDI-II, $r = -0.58$), ansiedad generalizada (GAD-7, $r = -0.52$) y desregulación emocional del DERS ($r = -0.66$). Correlación directa elevada con bienestar subjetivo, resiliencia y afecto positivo (PANAS-P, $r = 0.51$).
Sensibilidad al Tratamiento	Extraordinaria sensibilidad en ensayos clínicos controlados de intervenciones basadas en competencias emocionales (TEK, DBT y TCC transdiagnóstica), con ganancias de gran tamaño de efecto (d de Cohen = 0.90 a 1.30) tras 12 sesiones.
Invarianza Transdiagnóstica	Invarianza de medida ratificada entre diferentes diagnósticos clínicos (depresión unipolar, trastornos de ansiedad y TLP), demostrando que las 9 habilidades capturan el núcleo transdiagnóstico común de la desregulación emocional.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 27 reactivos se responde en función de la última semana en escala de 5 puntos (**0** = «No del todo», **1** = «Pocas veces», **2** = «Algunas veces», **3** = «Frecuentemente», **4** = «Casi siempre»):

- **Paso 1 (Cálculo Directo):** No contiene reactivos invertidos; todos los ítems evalúan la presencia positiva de habilidades.
- **Paso 2 (Puntuación por Habilidad - 3 ítems c/u):** Suma de los 3 reactivos correspondientes a cada dominio (Rango: **0 a 12 puntos**) o media del dominio (Rango: **0.00 a 4.00**).
- **Paso 3 (Puntuación Total ERSQ):** Suma aritmética de los 27 reactivos (Rango: **0 a 108 puntos**) o Media Global (Rango: **0.00 a 4.00**). A mayor puntuación, mayor destreza regulatoria adaptativa.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y SIGNIFICACIÓN DIAGNÓSTICA (BERKING, 2008)

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Competencia	Conducta Asistencial Recomendada
Déficit Severo	0 a 45 puntos	Desregulación masiva (corte < 46)	Incapacidad para sostener o modular emociones. Alto riesgo autole-sivo o adictivo. Prioridad para DBT/TEK.
Bajo / Clínico	46 a 64 puntos	Habilidades reducidas / Frágil	Vulnerabilidad afectiva manifiesta ante crisis; uso predominante de evitación o supresión desadaptativa.
Moderado / Medio	65 a 85 puntos	Competencia adaptativa media	Repertorio suficiente para la vida cotidiana; ocasionales dificultades ante sobrecargas extremas.
Alto / Resiliente	86 a 108 puntos	Alta destreza regulatoria	Excelente consciencia, aceptación y modulación afectiva. Factor protector de resiliencia sobresaliente.

PERFIL DE DESCONEXIÓN: ALTA CONSCIENCIA PERO NULA TOLERANCIA:

Un hallazgo clínico recurrente en pacientes con Trastorno Límite o Ansiedad Generalizada es presentar puntuaciones muy elevadas en **Consciencia y Sensaciones Corporales** (**> 3.0**) coexistiendo con puntajes colapsados en **Tolerancia al Malestar y Autovalidación** (**< 1.0**). Esta disociación genera hipersensibilidad fóbica a los propios afectos. La terapia debe focalizarse en la tolerancia y el autocalmado antes de seguir ampliando el registro emocional.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO MODULAR EN COMPETENCIAS EMOCIONALES (TEK)

PROTOCOLO CLÍNICO BASADO EN EL PERFIL DEL ERSQ-27:

- **Paso 1 (Mapeo de la Cadena Regulatoria):** Graficar las 9 subescalas. Identificar los eslabones rotos: ¿Falla en el registro inicial (Consciencia/Claridad)? ¿Falla en la tolerancia (Aceptación/Tolerancia)? ¿O falla en la autoayuda (Autovalidación/Modificación)?
- **Paso 2 (Entrenamiento Secuencial TEK):** Aplicar la "Secuencia TEK": Relajación muscular rápida -> Respiración calmante -> Posición corporal compasiva -> Aceptación verbal ("permite esta emoción") -> Autovalidación compasiva -> Reevaluación cognitiva.
- **Paso 3 (Monitorización Semanal):** Un incremento de **>= 15 puntos** en el total del ERSQ a la semana 8 señala consolidación de competencias adaptativas y disminución del riesgo de recaídas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y ATRACONES

Identificación: Mujer de 26 años, empleada administrativa, derivada por Trastorno por Atracón y sintomatología ansioso-depresiva severa. Describe episodios nocturnos de ingesta voraz incontrolada desencadenados por discusiones interpersonales o soledad ("la comida es la única forma de apagar la angustia").

Evaluación Inicial ERSQ-27 (Línea Base): Puntuación Total = **28/108 puntos** (Déficit Severo de Regulación). Desglose por medias: Claridad = 1.00; Tolerancia al Malestar = 0.33 (ítem 18 y 26 = 0); Autovalidación = 0.33; Aceptación = 0.67; Modificación = 0.67. Consciencia Atencional = 2.33.

Intervención Implementada: 14 sesiones del programa TEK integrando habilidades de DBT. Se entrenó la técnica de "surfear la ola emocional" ante el craving de atracón, autocompasión explícita con el ejercicio de la mano en el corazón y reestructuración de la intolerancia afectiva.

Reevaluación a las 14 Semanas: ERSQ Total ascendió a **76/108 puntos** (+48 pts, normalización al Rango Medio Adaptativo). Tolerancia al Malestar subió a 2.67; Autovalidación ascendió a 3.00; Aceptación a 2.67. Los episodios de atracón se redujeron en un 90% (de 5 semanales a 0-1 esporádico), con remisión del ánimo depresivo.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CONDUCTAS AUTOLESIVAS COMO REGULACIÓN:

En pacientes con Tolerancia al Malestar próxima a 0, las autolesiones no suicidas, atracones o consumos tóxicos actúan como intentos desesperados de regularización del afecto. Priorizar el contrato de seguridad y habilidades de tolerancia al malestar de DBT (TIPP).

MODIFICACIÓN VS. SUPRESIÓN COMPULSIVA:

La Modificación Activa debe distinguirse de la supresión afectiva disfuncional. Modificar una emoción requiere haberla aceptado y comprendido previamente; forzar el pensamiento positivo sin validar el dolor genera efecto rebote.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Berking, M., & Znoj, H. (2008). Development and validation of a questionnaire assessing emotion regulation skills. *BMC Psychiatry*, 8, 71.
2. Berking, M., Wirtz, C. M., Svaldi, J., & Hofmann, S. G. (2014). Emotion regulation predicts symptoms of depression over five years. *Behaviour Research and Therapy*, 57, 13-20.
3. Gómez-Acosta, A., et al. (2020). Propiedades psicométricas del Cuestionario de Habilidades de Regulación Emocional en población hispanoparlante. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 52, 115-125.
4. Berking, M. (2010). *Training Emotional Kompetenzen (TEK)*. Springer-Verlag.